

Nr. 133 Kommissarische Besprechung im Reichsinnenministerium vom 18. August 1939, 10 – 11.45 Uhr

R 43 II/721a, Bl. 35–41 Niederschrift des RIM, Umdruck¹

Anwesend: MDgt. Cropp (Vorsitz), MR Linden, ORR Ruttke, Lehmkuhl, Grau, MinOberKommissär Petz, RR Eckelberg, AR Franke (RIM); Reichsgesundheitsführer Conti; ORR Claassen (StdF); OLGR Maßfeller (RJuM); MR Günther (RAM); Ref. Ott, RAss. Klimbacher (österreich. Innenmin.); MedR Vellguth (Stadt Wien).

Beginn: 10:00

Beginn: 11:45

Ort: Reichsinnenministerium

[EINFÜHRUNG DES ERBGESUNDHEITS- UND DES EHEGESUNDHEITSGESETZES IN DER OSTMARK UND IM SUDETENGAU]

Teilnehmer s. beiliegende Anwesenheitsliste.

Nach Begrüßung der Teilnehmer gab der *Verhandlungsleiter* von den besonderen Schwierigkeiten Kenntnis, die sich in der Ostmark und im Sudetengau aus der Nichteinführung des Ehegesundheitsgesetzes² wie auch des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses³ im Laufe der Zeit entwickelt haben und die seiner Ansicht nach eine möglichst beschleunigte Einführung der beiden Gesetze geboten erscheinen lassen. Zur Klarstellung der Rechtslage verwies ORR Dr. Ruttke darauf, daß einerseits das Ehegesundheitsgesetz in der Ostmark bisher nicht in Kraft getreten ist, daß aber andererseits durch die Verordnung über die Einführung des deutschen Personenstandsrechts im Lande Österreich vom 2. Juli 1938 – RGBl. I S. 803 – das Personenstandsgesetz vom 3. November 1937⁴ – RGBl. I S. 1146 – und die 1. Verordnung hierzu⁵ am 1. Januar 1939 in der Ostmark eingeführt worden ist. § 20 der vorgen. 1. Verordnung bestimme im Absatz 1, daß bis zum Inkrafttreten des § 2 des Ehegesundheitsgesetzes⁶ und des § 7 der Ersten Verordnung zur Ausführung des Blutschutzgesetzes⁷ der Standesbeamte die Vorlegung eines Eheauglichkeitszeugnisses nur verlangen dürfe, wenn er begründete Zweifel habe, ob ein Ehehindernis im Sinne des § 1 des Ehegesundheitsgesetzes oder des § 6 der Ersten Verordnung zur Ausführung des Blutschutzgesetzes vorliege oder nicht.

¹ Den in der Sitzung vertretenen Stellen am 4. 9. 1939 übersandt; R 43 II/721a, Bl. 34 (APK II, Reg. Nr. 13761); auch in R 1501/5422, S. 307–321. Zu der Besprechung hatte der RIM am 3./10. 8. 1939 eingeladen, zunächst auf den 17. 8.; R 43 II/721a, Bl. 32 f. Vgl. GANSSMÜLLER, Erbgesundheitspolitik, S. 113–115. Ausgehend vom unmittelbaren Anlaß der Übernahme eugenischer Vorschriften des Altreichs auf die neuen Reichsgaue kamen im zweiten Teil der Besprechung virulente, seit 1937 schwebende Streitfragen der Anordnung von Zwangssterilisationen und eines neuen Kompetenzzuschnitts für Staat und Partei im Gesundheitswesen zur Sprache; Vorgeschichte und Konfliktlage s. ARH IV, Nrr. 91, 100, 157, 180, 183; ARH V, Nrr. 108 P. 1, 111.

² Gesetz zum Schutze der Erbgesundheit des deutschen Volkes (EhegesundheitsG) vom 18. 10. 1935 (RGBl. I S. 1246); s. ARH II/1, Nr. 117; II/2, Nrr. 231, 246 P. 3.

³ Sog. ErbgesundheitsG vom 14. 7. 1933 (RGBl. I S. 529); s. ARH I/1, Nr. 193 P. 7.

⁴ S. ARH IV, Nr. 137.

⁵ 1. AusfVO zum PersonenstandsG vom 19. 5. 1938 (RGBl. I S. 533).

⁶ § 2 EhegesundheitsG sah die allgemeine, nicht nur auf Zweifelsfälle beschränkte Vorlage von Ehegesundheitszeugnissen vor, wurde aber nie in Kraft gesetzt; s. ARH II/2, Nr. 231 Anm. 5–6.

⁷ Vom 14. 11. 1935 (RGBl. I S. 1334); s. ARH II/2, Nr. 260.

Vor Verabschiedung der 2. Verordnung zur Einführung des deutschen Personenstandsrechts im Lande Österreich vom 23. Dezember 1938 – RGBL. I S. 1919 – sei damit gerechnet worden, daß die Einführung des Ehegesundheitsgesetzes im Lande Österreich beschleunigt erfolgen würde. Aus diesem Grunde sei s. Zt. davon Abstand genommen worden, eine Übergangsvorschrift zu § 20 der 1. Ausführungsverordnung zum Personenstandsgesetz für das Land Österreich einzuführen. Aus der Nichteinführung dieser habe sich nun im Laufe der Zeit eine unhaltbare Rechtslage ergeben, die ihren Niederschlag in vielfachen Eingaben an das Ministerium finde. Das Ministerium für innere und kulturelle Angelegenheiten in Wien selbst habe zu einem dieser Fälle folgendermaßen Stellung genommen:

„Das Gesetz zum Schutze der Erbgesundheit des deutschen Volkes vom 18. 10. 1935 – RGBL. I S. 1246 – ist im Lande Österreich noch nicht in Kraft getreten. Es haben jedoch die Standesbeamten insoweit auf dessen Bestimmungen Rücksicht zu nehmen, als sie gemäß § 20 der 1. Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes vom 21. Mai 1938⁸ – RGBL. I S. 533 – bis zum Inkrafttreten des § 2 des Ehegesundheitsgesetzes die Vorlage eines Ehetauglichkeitszeugnisses zu verlangen haben, wenn begründete Zweifel bestehen, ob ein Ehehindernis im Sinne des § 1 dieses Gesetzes oder des § 6 der 1. Verordnung zur Ausführung des Gesetzes zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre vorliegt. Da in der 2. Verordnung über die Einführung des deutschen Personenstandsrechts im Lande Österreich vom 23. Dezember 1938 – RGBL. I S. 1919 – die Wirksamkeit des § 20 der 2. Ausführungsverordnung zum Personenstandsgesetz weder beschränkt noch ausgeschlossen ist, muß angenommen werden, daß dessen Bestimmungen auch im Lande Österreich seit 1. Januar 1939 in vollem Umfange in Kraft stehen.

Mit dieser Auffassung stehen im Widerspruch die Bestimmungen des § 106 des Gesetzes zur Vereinheitlichung des Rechts der Eheschließung und der Ehescheidung im Lande Österreich und im übrigen Reichsgebiet (Ehegesetz) vom 6. Juli 1938⁹ – RGBL. I S. 807 –, demzufolge die Vorschriften dieses Gesetzes, soweit sie sich auf das Ehegesundheitsgesetz beziehen (§§ 5, 20 und 28) im Lande Österreich nicht anzuwenden sind[,] und die des § 49 der Durchführungsverordnung zum Ehegesetz¹⁰, die bis 31. Dezember 1938 in Geltung standen; hier ist als Sondervorschrift für das Land Österreich angeordnet, daß der Standesbeamte nur bei Zweifel, ob ein Ehehindernis im Sinne des § 6 der 1. Ausführungsverordnung zum Blutschutzgesetz vorliegt, die Beibringung eines Ehetauglichkeitszeugnisses des Amtsarztes zu verlangen hat; der § 1 des Ehegesundheitsgesetzes wird hier nicht erwähnt.

Es werfen sich daher folgende Fragen auf:

– 1.

Ergibt sich aus § 106 des Ehegesetzes und der Fassung des § 49 der Durchführungsverordnung zum Ehegesetz, daß der Standesbeamte im Lande Österreich bei Zweifel[n], ob ein Ehehindernis nach § 1 des Ehegesundheitsgesetzes vorliegt, die Beibringung eines Ehetauglichkeitszeugnisses nicht verlangen darf und daher eine Eheschließung Erbkranker, wenn die Brautleute auf Grund der Beratung und Aufklärung durch den Standesbeamten bzw. den Amtsarzt nicht freiwillig zurücktreten, nicht verhindert werden kann?

– 2.

Sind im Lande Österreich die Bestimmungen des § 20 der 1. Ausführungsverordnung zum Personenstandsgesetz im vollen Umfange wirksam und hat daher im vorliegenden Falle der Standesbeamte richtigerweise die Vorlage des Ehetauglichkeitszeugnisses verlangt? Bejahendenfalls erman gelt es für das Land Österreich an einer Bestimmung über den Instanzenzug bei Verweigerung der Ausstellung des Zeugnisses durch den Amtsarzt, weil Erbgesundheitsgerichte hier noch nicht

⁸ Richtig: 19. Mai 1938 (o. Anm. 5).

⁹ Näheres s. ARH V, Nrr. 127, 129, 139.

¹⁰ Vom 27. 7. 1938 (RGBL. I S. 923).

bestehen. Nach meinem Dafürhalten kann wohl im Verwaltungswege über das Ehehindernis des § 1 des Ehegesundheitsgesetzes nicht entschieden werden.“

Die aus schriftlichen Berichten bekanntgewordene Rechtsunsicherheit sei auch durch wiederholte mündliche Berichte von Amtsärzten bestätigt worden. Falls eine Lösung durch Einnahme des formalen Rechtsstandpunktes gesucht würde und die Behörden im Lande Österreich dahin verständigt würden, daß das Ehegesundheitsgesetz im Lande Österreich noch nicht in Kraft getreten wäre, würde die Eheschließung von erbpflegerisch unerwünschten Ehen nicht verhindert werden können. Ein solches Vorgehen sei jedoch unzweckmäßig, weil dadurch nationalsozialistisch gesinnte Standesbeamte und Amtsärzte in eine schwierige Lage gebracht werden. Aus erbpflegerischen und weltanschaulichen Gründen wie auch aus Gründen der Rechtssicherheit sei die Beachtung der vom Nationalsozialismus geschaffenen Ehehindernisse notwendig. Daher müsse denjenigen, denen die Ausstellung des Eheauglichkeitszeugnisses durch den Amtsarzt verweigert worden ist, die Möglichkeit gegeben werden, bei der zuständigen Stelle Beschwerde einzulegen. Im § 11 der 1. Verordnung zur Ausführung des Ehegesundheitsgesetzes ist hierfür das Erbgesundheitsgericht vorgesehen.

Die Einführung der Erbgesundheitsgerichtsbarkeit selbst beruhe wiederum auf dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Aus der vom Gesetzgeber vorgenommenen Verkoppelung des Ehegesundheitsgesetzes mit dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses ergebe sich für die Beseitigung der geschilderten Rechtsunsicherheit die Notwendigkeit der gleichzeitigen Einführung des Ehegesundheitsgesetzes und des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Hierneben dürfe der derzeitige für die Dauer unhaltbare Zustand nicht verkannt werden, der deutschen Staatsangehörigen, denen im Altreich vom zuständigen Amtsarzt die Ausstellung des Eheauglichkeitszeugnisses verweigert worden ist, jetzt die Möglichkeit gibt, nach der Ostmark oder dem Sudetengau zu verziehen, um dort von dem zuständigen Standesbeamten die Eheschließung vollziehen zu lassen, ohne daß sie hierwegen später strafrechtlich belangt werden können.

Neben diesen aus der Nichteinführung des Ehegesundheitsgesetzes herrührenden Schwierigkeiten dürften die Mißhelligkeiten nicht verkannt werden, die sich in den in Rede stehenden Gebieten aus der Tatsache der Nichteinführung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses ergeben. Z. Zt. sei die Lage so, daß ein deutscher Staatsangehöriger, der im Altreich auf Grund des Beschlusses eines Erbgesundheitsgerichts oder Erbgesundheitsobergerichts unfruchtbar gemacht werden soll, die Möglichkeit hat, nach der Ostmark oder dem Sudetengau zu verziehen. Eine Möglichkeit, ihn hier unfruchtbar zu machen, bestehe z. Zt. nicht, weil er einmal wegen der Nichteinführung des Gesetzes in der Ostmark und im Sudetengau nicht mit Hilfe polizeilichen Zwanges zwecks Durchführung der Unfruchtbarmachung in das Altreich zurückgebracht werden kann. Andererseits seien Unfruchtbarmachungen in der Ostmark und im Sudetengau nicht möglich, weil mangels gesetzlicher Vorschriften vom Gesetzgeber zugelassene Krankenhäuser und Ärzte nicht vorhanden sind und außerdem auch die Krankenkassen und Fürsorgeverbände nicht verpflichtet sind, die entstehenden Kosten zu übernehmen.

Weiterhin verlange die Bekämpfung der in dem Sudetengau herrschenden Abtreibungsseuche dringend die Einführung der im Art. 12 der 4. Durchführungsverordnung zum Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses¹¹ vorgesehenen Meldepflicht. So habe der Regierungspräsident in Karlsbad in einem Bericht darauf verwiesen, daß in einem Kreise seines Bezirks z. Zt. (Juli 1939) eine ganze Reihe von Abtreibungsermittlungsverfahren, in welchen auch eine Reihe von Ärzten verwickelt sind, schweben. Das Abtreibungsdezernat der Kriminalpolizei in Karlsbad bearbeite augenblicklich 30 verschiedene Abtreibungsermittlungsverfahren. Eine Klärung der Ursachen der zahlreichen Fehlgeburten und Frühgeburten, die sich trotz der Aufklärung der Bevölkerung in bevölkerungspolitischer Hinsicht immer noch ereignen, und die ohne Frage oft kriminell bedingt sind, sei nur möglich, wenn die in Art. 12 der Vierten Verordnung zur Ausführung des Gesetzes zur Verhü-

¹¹ Vom 18. 7. 1935 (RGBl. I S. 1035); s. ARH II/2, Nr. 178 Anm. 5.

tung erbkranken Nachwuchses vorgeschriebene Anzeigepflicht über Fehlgeburten, Frühgeburten und Schwangerschaftsunterbrechungen baldmöglichst eingeführt wird.

Nach Ansicht des Berichterstatters müsse die durch die Nichteinführung des Ehegesundheitsgesetzes und des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses in der Ostmark und im Sudetengau eingetretene außerordentlich große Rechtsunsicherheit so schnell wie möglich behoben werden. Insbesondere sei es s[einer] A[nsicht] nach wichtig, bei der in der Ostmark und im Sudetengau festgestellten starken Ehefreudigkeit bezüglich der Eheschließung und der Verweigerung der Eheschließung die Lücken der Gesetzgebung zu schließen.

Seitens des Vertreters des Reichsjustizministeriums, *Oberlandesgerichtsrat Maßfeller*, wurde den Ausführungen des Berichterstatters in vollem Umfange beigetreten. Die Rechtslage selbst sei zwar undurchsichtig. Tatsache sei jedoch, daß die in dem Referat wiedergegebene Rechtsunsicherheit bestehe. S[einer] M[einung] nach lasse sich zwar die Ansicht vertreten, daß das Ehegesundheitsgesetz in der Ostmark gelte; zugegeben müsse jedoch werden, daß diese Annahme auf recht tönernen Füßen stehe. Die in den beteiligten Standesbeamtenkreisen herrschende Unsicherheit sei für ihn aus vielen Anfragen, die an ihn gelegentlich eines Schulungslehrgangs gerichtet worden sind, klar geworden. Hierbei seien insbesondere Aufschlüsse darüber gewünscht worden, wie zu verfahren sei,

– a)

wenn der Amtsarzt sich weigere, überhaupt tätig zu werden,

– b)

wenn das Ehetauglichkeitszeugnis vom Amtsarzt versagt werde und die Verlobten sich weigern, dies anzuerkennen?

Standesbeamte und Aufsichtsbehörden seien sich über die Rechtslage im Zweifel. Die Mehrzahl der Standesbeamten sei der Meinung, der Standesbeamte habe sich an den § 20 der 1. Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes vom 19. Mai 1938 zu halten. Die Amtsärzte werden in der Regel tätig; einige hätten dies jedoch abgelehnt mit der Begründung, daß das Ehegesundheitsgesetz in der Ostmark noch nicht gelte. Im Falle der Verweigerung des Ehetauglichkeitszeugnisses sei nach dem derzeitigen Stande keine Stelle vorhanden, durch die eine Nachprüfung eingeleitet werden könne, mit Ausnahme des Ansuchens um Befreiung an das Reichsministerium des Innern. Formell gesehen sei das Ehegesundheitsgesetz in der Ostmark nicht eingeführt; auf Grund des § 20 der 1. Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes könne eine Forderung zur Beibringung des Ehetauglichkeitszeugnisses nicht erhoben werden. Als untragbar müsse es s. A. nach weiterhin bezeichnet werden, daß Personen, denen in einem anderen Teile des Großdeutschen Reiches die Ehegenehmigung versagt worden ist, in der Ostmark und im Sudetengau heiraten können. Bei dieser Sachlage wurde die Einführung des Ehegesundheitsgesetzes von dem Vertreter des Reichsjustizministeriums für dringend erforderlich gehalten. Die gleiche Stellungnahme bezüglich der Einführung des Ehegesundheitsgesetzes wurde von dem *Reichsgesundheitsführer* vertreten. Im Hinblick auf die Verquickung dieses mit dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses wurde von ihm als Voraussetzung herausgestellt, daß gleichzeitig auch das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses mit eingeführt werde. Da die Einführung dieses jedoch noch mit gewissen Bedingungen nach Änderung verknüpft sei, schiene es ihm geboten, zu versuchen, in der bestehenden Unstimmigkeit zwischen den Ressorts zu einer Übereinstimmung zu kommen, gegebenenfalls durch Einholung der Entscheidung des Führers selbst.

Oberregierungsrat Dr. Claassen verwies darauf, daß die Erwägungen wegen der Änderung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses bisher noch nicht abgeschlossen werden konnten, insbesondere sei es bisher noch nicht möglich gewesen, eine Entscheidung des Reichsministers Dr. Lammers hierzu zu erreichen.

Zu den bisher offen gebliebenen Punkten bei den Verhandlungen wegen der Änderung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses nahm *OLGR Maßfeller* wie folgt Stellung: Als strittig seien folgende 3 Punkte anzusehen:

– 1.

Beteiligung von Laienbeisitzern am Erbgesundheitsgerichtsverfahren.

– 2.

Erbgesundheitsgericht und Erbgesundheitsobergericht sollen verpflichtet sein, im Verfahren den zuständigen Gauleiter oder die von diesem bestimmte Stelle zu hören. Außerdem solle dem Gauleiter ein Beschwerderecht gegen die Entscheidung des EG. bzw. EOG. eingeräumt werden.

– 3.

Errichtung eines Ausschusses beim Reichsministerium des Innern. Dieser Ausschuß soll mit 2 Referenten des RMdI (Min. Direktor Dr. Gütt als Vorsitzender und ein weiteres Mitglied) und 3 vom Stellvertreter des Führers zu benennenden Ärzten besetzt sein. Er solle die Aufgabe haben, in schwebenden Verfahren Gutachten darüber zu erstatten, ob der Betroffene an einer Erbkrankheit im Sinne des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses leidet. Der Ausschuß solle in die Lage versetzt werden, die Entscheidungen des Erbgesundheitsgerichts bzw. -obergerichts zu revidieren.

Der Reichsminister der Justiz nähme hierzu folgendermaßen Stellung:

– 1.

Über die Beteiligung von Laienbeisitzern am Erbgesundheitsgerichtsverfahren würde sich eine Einigung erzielen lassen. (Hierzu bemerkte Dr. Linden, daß dieser Punkt nicht strittig sei.)

– 2.

Gegen die Beteiligung des zuständigen Gauleiters am Erbgesundheitsgerichtsverfahren sprächen folgende Bedenken: Für Verfahren, in denen Belange der Volksgemeinschaft wahrzunehmen sind, seien die Verwaltungsbehörden (Regierungspräsident) oder der Staatsanwalt zuständig. Strittig sei hierbei, ob nicht auch die Partei hierzu berufen ist. Es sei anzunehmen, daß sich eine Beteiligung des Gauleiters nicht sehr günstig auswirken würde, weil das EG. und das EOG. nicht gern gegen den Gauleiter Stellung nehmen werde. Bei einer Beteiligung des Gauleiters würde also die Unabhängigkeit der Gerichte praktisch beseitigt. Dagegen hätte der Reichsjustizminister keine Bedenken, wenn die Partei im Vorverfahren beteiligt wird, d. h. wenn die Partei sich vorher mit dem zuständigen Amtsarzt in Verbindung setzt, um ihre Bedenken gegen das Vorliegen einer Erbkrankheit oder gegen eine Unfruchtbarmachung des Betroffenen aus öffentlichen oder sonstigen Gründen zu äußern. Bei diesem Verfahren müsse jedoch dem Erbkranken auch ein Verteidigungsrecht eingeräumt werden, d. h. ihm müsse Gelegenheit gegeben werden, zu allen gegen ihn von der Parteidienststelle vorgebrachten Punkten Stellung zu nehmen. Die Parteidienststelle (Kreisleiter usw.) muß also gehalten werden, die Personen zu benennen, auf die sich ihre Behauptungen stützen.

– 3.

Errichtung eines Beschwerdeausschusses beim RMdI. Dieser Ausschuß sei vom Reichsjustizminister bisher abgelehnt worden. Hiervon Abstand zu nehmen, bestehe auch heute noch keine Geneigtheit. Die Stellungnahme des Reichsjustizministers hierzu sei in zwei Schreiben des Reichsjustizministeriums festgelegt¹².

Bei der Erbgesundheitsgesetzgebung sei die Entscheidung darüber, ob eine Erbkrankheit vorliegt oder nicht, den Gerichten übertragen worden. Wenn aber nun die Möglichkeit gegeben werde, in einem schwebenden Verfahren den Ausschuß anzurufen, so sei die Unabhängigkeit des Gerichts aufgehoben.

Im 2. Entwurf des RMdI¹³ sei die Bindung des Gerichts an die Ausschußgutachten formell beseitigt worden. Praktisch bedeute dies jedoch nichts. Entweder müsse das Gericht diese Ausschußgutachten anerkennen und seine Rechtsprechung danach einstellen oder aber es erkenne sie nicht an, was praktisch darauf hinauslaufen würde, daß die geschaffene Einrichtung überflüssig ist. Das Gericht würde somit nur ausführendes Organ dieses Ausschusses sein. Das sei für den Reichsjustiz-

¹² U. a. in der Stellungnahme an den RIM vom 15. 6. 1938: ARH V, Nr. 111 Anm. 5.

¹³ Gemeint ist der revid. Entw. eines „3. ErbgesundheitsÄndG“, vom RIM vorgelegt am 11./18. 6. 1938; s. ebd.

tizminister nicht tragbar. Festgehalten müsse daran werden, daß die endgültige Entscheidung das Gericht haben muß. Ebenso sei es nicht möglich, daß die Beschlüsse der Erbgesundheitsgerichte von diesem Ausschuß überprüft würden. Auch hier müsse daran festgehalten werden, daß der Rechtspruch eines Erbgesundheitsgerichts nur durch ein ebenso unabhängiges Gericht im Wiederaufnahmeverfahren aufgehoben werden kann. Nichts einzuwenden sei dagegen [gegen] ein Gnadenrecht, wie es der Führer auch sonst ausübe und das in diesem Falle einer bestimmten Stelle, z. B. dem Reichsminister des Innern, übertragen werden könnte.

Seitens der *Vertreter der Ostmark* (Dr. Ott, Dr. Klimbacher und Dr. Vellguth) wurde darauf verwiesen, daß Bedenken gegen eine alsbaldige Einführung der in Rede stehenden Gesetze in der Ostmark nicht bestünden. Dringend müsse unter allen Umständen um die beschleunigte Inkraftsetzung des Ehegesundheitsgesetzes gebeten werden, da Tatsachen, wie z. B. Heiraten entgegen den Bestimmungen des § 1 des Ehegesundheitsgesetzes wie auch Unterlassen dringender Sterilisierungsfälle[,] von der Bevölkerung nicht verstanden würden. Abgesehen hiervon sei die Rechtslage für die Standesbeamten derart heikel, daß als Folge eine nicht zu verkennende Unsicherheit zu beobachten sei. Zugegeben müsse werden, daß mangels entsprechender Vorschriften die Durchführung des Ehegesundheitsgesetzes vielerorts bereits jetzt illegal erfolge.

Der Bitte um beschleunigte Einführung beider Gesetze wurde vom *Vertreter des Reichsstatthalters im Sudetengau*¹⁴ wärmstens beigetreten. Die dortigen Heil- und Pflegeanstalten seien z. Zt. überfüllt. Ein großer Teil der zurückgehaltenen Erbkranken könne entlassen werden, wenn nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses die Unfruchtbarmachungen durchgeführt werden könnten. Weiterhin sei die Abtreibungsfrage für den Sudetengau sehr dringend. Den Abtreibern könne anders als bisher bei Einführung der Meldepflicht nachgegangen werden. Trotz Anerkennung der besonderen Schwierigkeiten, die in der Ostmark und im Sudetengau offensichtlich bestehen, hielt es der *Vertreter des Stellvertreters des Führers* im Hinblick auf die Schwierigkeiten, die sich bei der Durchführung des Sterilisierungsgesetzes im Altreich ergeben haben, für ratsamer, die Einführung der Gesetze bis nach Entscheidung des Führers zurückzustellen. Tatsache sei, daß eine ganze Reihe von Entscheidungen der Erbgesundheitsgerichte so ausgefallen sind [sic], daß ihre Durchführung unter allen Umständen unterbunden werden müsse. Die vom Stellvertreter des Führers gemachten Vorschläge sollten gerade dazu dienen, derartige Fehlbeschlüsse künftig zu vermeiden.

Da bei der augenblicklichen Lage zu erwarten stehe, daß die Einführung der Gesetze in der Ostmark und im Sudetengau trotz der inzwischen erfolgten weitgehenden Annäherung der Stellungnahmen des Reichsministers des Innern und des Stellvertreters des Führers u. U. recht lange auf sich warten lassen könne, hielt es der *Verhandlungsleiter* für geboten, beschleunigt das einzuführen, was praktisch zur Abstellung der beklagten Mängel durchgeführt werden müsse. Zur Frage, wie dies geschehen könne, ohne gegen den Standpunkt des Stellvertreters des Führers zu handeln, verwies *Min. Rat Dr. Linden* darauf, daß z. Zt. bereits die wichtigsten Differenzen, nämlich bei der Beurteilung des Schwachsinn und der Epilepsie¹⁵[,] zwischen den Sachbearbeitern des Reichsmin. des Innern und des Stellvertreters des Führers überhaupt nicht mehr beständen. Auch in den anderen Fragen bestehe bereits weitgehende Übereinstimmung, wieder andere unterlägen der wissenschaftlichen Klärung. Es sei kein Zweifel, daß man auch hier zu einer vollkommenen Einigung gelangen werde. Unerläßlich sei es aber, eine Instanz zu schaffen, die für die Beachtung der erarbeiteten Grundsätze bei der Rechtsprechung Sorge. Wie in diesen Fragen[,] so könne auch in jeder anderen Frage auftretenden Meinungsverschiedenheiten gesteuert werden. Keineswegs bestehe die Absicht, mit großem Elan sich auf die Durchführung der Gesetze in der Ostmark und im Sudetengau zu stürzen. Beabsichtigt sei vielmehr, nur die eklatantesten Fälle, bei denen keine Zweifel bestehen, in Angriff zu nehmen, so daß wohl hinsichtlich der praktischen Durchführung der Gesetze Schwierigkeiten kaum

¹⁴ Ein solcher in der Teilnehmerliste nicht aufgeführt.

¹⁵ Zu den Krankheitsbildern, die ein Sterilisierungsverfahren auslösen konnten, s. ARH I/1, Nr. 193 Anm. 20.

zu erwarten sein würden. Die seitens des Reichsarbeitsministeriums zu erlassenden Anordnungen wurden von dem Vertreter des *Reichsarbeitsministeriums* von der vorherigen Einführung der Gesetze abhängig gemacht.

Im Falle der Einführung der Gesetze in der vorerwähnten Form sollten nach Ansicht von *Oberlandesgerichtsrat Maßfeller* Schwierigkeiten nur noch bei dem zu bildenden Reichsausschuß bestehen. Falls die Partei im Vorverfahren beteiligt werde, werde es g[egebenen] F[alls] zu einer Antragstellung überhaupt nicht kommen, so daß es nicht mehr nötig sein werde, den Gauleiter beim Verfahren selbst zu beteiligen. Bereitwilligkeit des Reichsjustizministers bestehe, die Laienbeisitzer und die Einschaltung der Partei in das Vorverfahren zu übernehmen. Daß in der Frage des Reichsausschusses eine Entscheidung des Führers vorliegen solle, sei ihm bekannt¹⁶. Doch bezweifle der Reichsjustizminister, daß dem Führer die grundsätzlichen Bedenken gegen diese Lösung vorgetragen worden seien[,] und daher könne er die Entscheidung vorerst nicht als endgültig betrachten. Bei einem Rückblick auf die Entwicklung der Rechtsprechung im Erbgesundheitsgerichtsverfahren stehe fest, daß sich verschiedene Auffassungen über Erbkrankheiten heute gewandelt haben. Während beim angeborenen Schwachsinn anfänglich nur die ärztliche Diagnose ausschlaggebend gewesen sei, sei heute neben den Defekten wesentlich die Bewährung des Probanden im Leben maßgebend. Die klinische Diagnose sei also unter erbpflegerischen Gesichtspunkten zu prüfen, bevor sie zur Grundlage einer Entscheidung gemacht werde. Irrtümer werden, so lange Menschen Recht sprechen, immer möglich sein. Versuche, diese auszuschalten, werden nie ganz gelingen. Falls Fehlentscheidungen als solche erkannt werden, sei die Wiederaufnahme des Verfahrens erforderlich. S. A. nach solle der Reichsausschuß damit beauftragt werden, Richtlinien für die Beurteilung des angeborenen Schwachsinn, der Epilepsie usw. auszuarbeiten. Das Reichsjustizministerium sei gern bereit, diese Richtlinien den Gerichten mitzuteilen. Die Frage des Gnadenrechts werde hierbei verhältnismäßig leicht durch einen Beschluß des Führers, der die Übertragung des Rechts an das Reichsministerium des Innern – g.F. im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers – vorsehen könnte, zu regeln sein.

ORR Dr. Ruttké regte an, bei der weiteren Behandlung der Angelegenheit die Weiterbetreibung der Novelle von der Einführung der Gesetze in der Ostmark und im Sudetengau getrennt zu verfolgen, um so vorweg die dringendsten Fragen, die mit den Gesetzen in ihrer derzeitigen Fassung erledigt werden können, einer Klärung zuzuführen.

Die Frage des *Vertreters des Stellvertreters des Führers*, ob das Reichsministerium des Innern bereit sei, die Antragstellung auf Unfruchtbarmachung einer Person in der Ostmark und im Sudetengau von der vorherigen Zustimmung des Gauleiters abhängig zu machen, wurde von Verhandlungsführer und Sachbearbeiter (Min. Rat Dr. Linden) bejaht. Im Falle der sofortigen Einführung der beiden Gesetze stellte letzterer eine generelle Anweisung an die Amtsärzte der Ostmark und des Sudetengaus in Aussicht, daß ohne Zustimmung des Gauleiters kein Antrag gestellt werden dürfe. Diese Regelung solle bis zur Verabschiedung der Novelle in Kraft bleiben. Bei der Bearbeitung dieser sollen die gesammelten Erfahrungen mit verwertet werden.

Bei Betreibung der Angelegenheit in der beschlossenen Weise wurde als Einführungstag der 1. Oktober 1939 vorgesehen. *ORR Claassen* wird über die Angelegenheit dem Stellvertreter des Führers beschleunigt Vortrag halten und die Antwort in 5 und [sic] 6 Tagen einsenden. Die Frage von Dr. Linden, ob es nach den Ausführungen von Herrn Maßfeller über die Stellungnahme des Reichsjustizministeriums erwünscht sei, durch eine Beratung im engeren Kreise nochmals zu versuchen, zu einer Einigung zwischen den Ressorts zu gelangen, wurde von *ORR Claassen* und dem Reichsgesundheitsführer bejaht. Als Termin für diese Besprechung wurde Montag, 9. Oktober d. Js. vereinbart¹⁷.

¹⁶ Hierzu nichts ermittelt; vgl. aber die in ARH V, Nr. 111 von StS Pfundtner festgehaltene Einschätzung Lammers'.

¹⁷ Ohne Nachweis, unterblieb vermutlich. Statt dessen verfügte die mit Kriegsbeginn verkündete *DVO zum ErbgesundheitsG und zum EhegesundheitsG* vom 31. 8. 1939 (RGBl. I S. 1560), daß neue Sterilisierungsanträge nur „wegen besonders großer Fortpflanzungsgefahr“ gestellt werden dürften, bestehe diese nicht, sollten auch laufende Verfahren eingestellt und rechtskräftig

Mit Worten des Dankes für die Mitarbeit wurde die Beratung durch den Verhandlungsleiter um 11.45 Uhr geschlossen.

tige Beschlüsse der Erbgesundheitsgerichte ausgesetzt werden; Ehetauglichkeitsprüfungen hätten „im allgemeinen“ zu unterbleiben, Ehetauglichkeitszeugnisse dürften nur versagt werden, „wenn besonders schwere Schäden für die Volksgesundheit oder die Reinheit des deutschen Blutes oder ein Verlust wertvollen Erbgutes zu befürchten sind“. Diese DVO und mit ihr das *ErbgesundheitsG* sowie das *EhegesundheitsG* wurden schließlich in der Ostmark durch VO vom 14. 11. 1939 (RGBl. I S. 2230), im Sudetengau durch VO vom 15. 12. 1939 (RGBl. I S. 2434), jeweils zum 1. 1. 1940, auch förmlich eingeführt.

Zitierhinweis

Nr. 133 Kommissarische Besprechung im Reichsinnenministerium vom 18. August 1939, 10 – 11.45 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d133>